Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

Autor: Leonhardt
Datum: 02.02.2026
Schema: PS50P
KEINE_ABSCHNITTSPUNKTE: ja
FRAGE_NUMMERN: fortlaufend
KEINE_MARKIERUNGEN: nein
GUI_AUFTEILUNG: B 53
ABSCHNITTE_RANDOMISIEREN: ja
ABSCHNITT_R_MUSTER:
FRAGEN_RANDOMISIEREN: ja
ABSCHNITTE_OHNE_FRAGERANDOMISIERUNG:
ANTWORTEN_RANDOMISIEREN: ja
FRAGEN_OHNE_ANTWORTRANDOMISIERUNG:
MOBIL_GEEIGNET: ja

Das Kopieren von Schrift- und Bildmaterial während der Klausur mittels Handys, Kameras oder anderen technischen Geräten ist aus urheberrechtlichen Gründen untersagt. Verstöße werden mit **Nichtbestehen** der Klausur geahndet.

Allgemein gilt, dass die Verwendung nicht erlaubter Hilfsmittel während der Klausur im Sinne eines Täuschungsversuches zum Nichtbestehen der Klausur führt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Mobilfunkgeräte. Stellen Sie bitte sicher, dass sich diese **weder auf Ihrem Arbeitsplatz noch in unmittelbarer Nähe dazu befinden** und dass die Geräte ausgeschaltet sind.

Bewertungsschema:

TypA (Einfachauswahl bei 5 Antwortalternativen): Jede Abweichung von der vorgegebenen Lösung ergibt 0%.
PickS (x aus y Antwortalternativen sind auszuwählen): PickS (scharfe Mehrfachauswahl): Sind mehr als die Hälfte der Antworten richtig klassifiziert (Kreuz bei einer zutreffenden Aussage bzw. kein Kreuz bei einer nicht zutreffenden Aussage), erhält man 50%, bei mehr Abweichungen 0%. Die Zahl der auszuwählenden Antworten ist angegeben. **Wählen Sie weniger bzw. mehr Antwortalternativen aus als angegeben sind, erhalten Sie automatisch 0 Punkte.**
Kprim (zu jeder Aussage muss eine Ja/Nein Entscheidung getroffen werden): Bei 4 erwarteten Entscheidungen ergibt eine Abweichung von der vorgegebenen Lösung noch 50%, ansonsten 0%.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

1. Welche der folgenden Aussagen zum Endometriumkarzinom trifft am ehesten zu?
Typ: TypA
a) Die Erkrankung zeigt sich häufig bei Erstdiagnose schon primär metastasiert.
b) Im Fall der Metastasierung ist die Therapie der Wahl Medroxyprogesteronacetat (MPA) als Erstlinie.
c) Technetium wird meist für die Markierung des Wächterlymphknotens verwendet.
d) Lokalrezidive entstehen in der Regel postoperativ in Form einer Fern-Metastasierung außerhalb des kleinen Beckens.
e) Eine Hormonersatztherapie kann das Risiko für die Entstehung eines Endometriumkarzinoms erhöhen.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

2. Welche der folgenden Aussagen zum Vulvakarzinom trifft am ehesten zu?

Typ: TypA

- **a)** Es besteht keine Möglichkeit der Impfprävention.
- b) Das Vulvakarzinom entsteht in der Regel de novo.
- c) Der primäre Weg der Metastasierung des Vulvakarzinoms ist meist hämatogen.
- d) **Das Risiko für eine Metastasierung steigt mit der Tiefe der Infiltration des Karzinoms.**
- e) Im Zuge der Nachsorge sollte regelmäßig eine CT-Untersuchung des Beckens erfolgen.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

3. Welche der folgenden Aussagen zum Endometriumkarzinom trifft am ehesten zu?
Typ: TypA

- a) Bei Infiltration der Cervix uteri durch das Carcinom besteht die Indikation zur einfachen Hysterektomie mit Adnexektomie beidseits.
- **b) Es gibt keine Screeningmöglichkeit für diese Erkrankung.**
- c) Eine Mutation der MMR-Defizienz hat keinen Einfluss auf die Prognose.
- d) Eine Mutation von p53 spricht für eine gute Prognose.
- e) Der erste Therapieschritt besteht, wenn möglich, in Chemotherapie.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

4. Ein Kriterium für eine genetische Testung im Rahmen der FBREK (Familiärer Brust- und Eierstockkrebs) Zentren ist folgendes:
Typ: TypA

- a) 1 Mann mit Magenkarzinom, 1 Frau mit Mammakarzinom im Alter von 65 Jahren
- b) 1 Frau mit Mammakarzinom im Alter von 40 Jahren
- **c) 1 Mann mit Mammakarzinom (HER2+, HER2-) im Alter von 50 Jahren**
- d) 1 Frau mit Pankreaskarzinom, 1 Frau mit Mammakarzinom im Alter von 80 Jahren
- e) 1 Frau mit Ovarialkarzinom im Alter von 85 Jahren

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

5. Wie schätzen Sie folgende Aussagen zum genetischen Hintergrund des Mammakarzinoms ein?
Typ: Kprim

- **a) Bei der Keimbahnanalyse einer gesunden Frau mit auffälliger Familienanamnese handelt es sich um eine prädiktive Testung**
- b) Eine genetische Untersuchung auf Keimbahnmutationen erfolgt in der Regel aus dem Tumorgewebe
- c) Eine Keimbahnanalyse im Rahmen von FBREK (Familiärer Brust- und Eierstockkrebs) kann auch vor dem 18. Lebensjahr erfolgen
- d) Die Wahrscheinlichkeit zur Vererbung einer pathogenen BRCA1-Mutation liegt bei 45%

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

6. Welche der folgenden Maßnahmen trägt am zuverlässigsten zur Primärprävention des Zervixkarzinoms bei?

Typ:TypA

- **a)** Regelmäßige Kolposkopie ab dem 20. Lebensjahr
- **b) HPV (Humanes Papilloma Virus)-Impfung vor dem ersten Geschlechtsverkehr**

Commented [EA1]: Diese Frage ist für eine KPrim komisch formuliert...
Lieber eher:
Welche der folgenden Aussagen zum genetischen Hintergrund des Mammakarzinoms trifft bzw. treffen zu?

c) Pap-Abstrich jährlich ab dem 16. Lebensjahr
d) Prophylaktische Konisation bei persistierenden HPV-Infektionen
e) Serologische HPV (Humanes Papilloma Virus)-Testung im 5-Jahres-Abstand

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

7. Beurteilen Sie folgende Aussagen zur Therapie des Zervixkarzinoms. Welche der Aussagen trifft bzw. treffen zu und welche nicht?

Typ:Kprim

a) Bei frühen Tumorstadien (z. B. IA1) kann eine Konisation ausreichend sein.
b) Die primäre Radiochemotherapie ist Standard im lokal fortgeschrittenen Stadium.
c) Eine Sentinel-Lymphknotenbiopsie ist beim Zervixkarzinom nicht etabliert.
d) Eine Operation ist in der Schwangerschaft grundsätzlich kontraindiziert.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

8. Wählen Sie die drei zutreffenden Aussagen zur Diagnostik des Ovarialkarzinoms:

Typ: PickS

a) Der Tumormarker CA-125 ist für das Screening uneingeschränkt geeignet.

b) Die transvaginale Sonographie ist die wichtigste bildgebende Erstuntersuchung.

c) Ovarialkarzinome werden häufig erst in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert.

d) Das CT (Computertomographie) kann zur präoperativen Ausbreitungsdiagnostik eingesetzt werden.

e) Eine Biopsie der Ovarien ist vor einer geplanten Primäroperation obligat.

f) Der Tumormarker Ca-15-3 ist ein spezifischer Marker für das Ovarialkarzinom.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

Eine 30-jährige Patientin kommt in die gynäkologische Notfallambulanz mit Unterbauchschmerzen.

--

9. Welche der folgenden Untersuchungen sollte bzw. sollten zuerst zur besseren Einschätzung der Situation und Ursache der Beschwerden erfolgen und welche nicht?

Commented [EA2]: Anzahl-Cue vermeiden...

Typ: Kprim

a) Urinuntersuchung
b) Gynäkologische Untersuchung
c) Magnetresonanztomographie des Beckens

d) **Gynäkologischer Ultraschall**

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

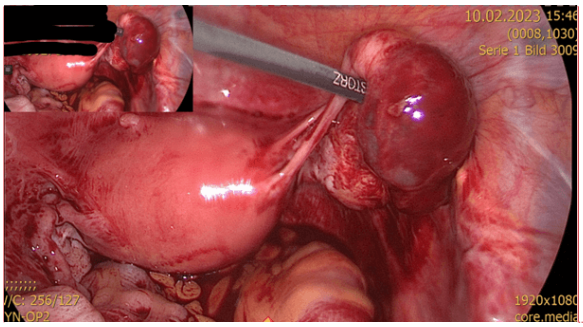
10. Welche Aussage zu den folgenden Notfällen/Erkrankungen ist am ehesten richtig?

Typ: TypA

a) Bei V.a. eine Ovarialtorsion wird in der Regel eine elektive Laparoskopie geplant.
b) Bei einer Eileitergravidität wird zwischen einer medikamentösen und operativen Therapie abhängig von der Situation und dem Zustand der Patientin entschieden.
c) Eine Adnexitis wird meistens durch eine intraabdominale Durchwanderung von Darmbakterien verursacht.
d) Die Endometriose ist eine Erkrankung, die vor allem Frauen in der Perimenopause betrifft.
e) Myome sollten in der Regel operativ entfernt werden.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26



Quelle: Universitätsklinikum Würzburg

--

11. Was stellt dieser intraoperative Befund am Ehesten dar?

Typ: TypA

a) Ein intraligamentäres Uterusmyom.
b) Ein Endometriom („Schokoladenzyste“).
c) Eine Tubargravidität.
d) Eine Adnexitis.
e) Eine Ovarialtorsion.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

12. Welche Aussage zur Endometriose ist am ehesten richtig?

Typ: TypA

Commented [EA3]: Bild in Größe reduziert

a) Eine Endometriose lässt sich in der Regel einfach sonographisch sicher diagnostizieren.
b) 90% der Patientinnen mit Endometriose leiden an einer geminderten Fertilität.
c) Treten chronische Unterbauchschmerzen und unerfüllter Kinderwunsch zusammen auf, ist an eine Endometriose unbedingt zu denken.
d) Eine operative Sanierung der Endometriose ist in jedem Falle, allein zur Sicherung der Diagnose, indiziert.
e) Unter den hormonellen Therapien ist die Therapie mit einem Antagonisten des Gonadotropin-releasing-Hormons Mittel der ersten Wahl.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

Eine 32-jährige Frau IIG IP in der Schwangerschaftswoche 35+4 mit einer gesicherten HIV (Humanes Immundefizienz-Virus) -Infektion wünscht eine Beratung hinsichtlich der Entbindung.

Deleted: mit
Deleted: 35+4
Deleted: n
Deleted: (SSW
Deleted:) und

--

13. Welche der folgenden Beratungsaspekte ist bzw. sind richtig?

Typ: Kprim

a) **Die Entscheidung bezüglich des Entbindungsmodus richtet sich nach geburtshilflichen Aspekten, nach den Wünschen der Schwangeren sowie nach der Höhe der HIV-RNA (Ribonukleinsäure) im mütterlichen peripheren Blut vor der Entbindung.**
b) Frauen mit HIV-RNA > 1000 Kopien/ml sollte eine vaginale Geburt ermöglicht werden.
c) Peripartal besteht das niedrigste Risiko einer HIV-Infektion des Kindes.
d) Eine antiretrovirale Therapie bei Schwangeren mit HIV-Infektion kann die Mutter-Kind-Transmission von HIV auf <1% reduzieren

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

14. Welche der folgenden Aussagen zu Erregern im Bereich der Vagina und Vulva treffen zu?
Typ:PickS

a) Trichomonaden können durch Geschlechtsverkehr übertragen werden.
b) Wegen des Risikos einer Sterilität sollte eine Herpes genitalis Infektion immer behandelt werden
c) B-Streptokokken in der Vagina führen bei Frauen in der reproduktiven Phase in Regel zu keiner Infektion. Es handelt sich nur um eine asymptomatische Besiedlung.
d) Eine gestörte Vaginalflora ist meistens mit einer Erhöhung der Anzahl von der Laktobazillen in der Vagina assoziiert.
e) Hinweis auf eine vaginalen Pilzinfektion ist ein dünnflüssiger, leicht nach Fisch riechender Fluor.
f) Die Leitkeime bei der bakteriellen Vaginose sind Gardnerellen.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

15. Bei welcher der folgenden Infektionen in der Frühschwangerschaft können Sie infektionsbedingte typische embryonale und/oder fetale Fehlbindungen nahezu ausschließen?

Typ: Typ A

a) Toxoplasmose
b) Röteln
c) Lues

d) **Streptokokken-Infektion**
e) Infektion mit Zikaviren

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

16. Welche der folgenden Aussagen zur Belastungsharninkontinenz (Stressinkontinenz) der Frau trifft bzw. treffen zu und welche nicht?

Typ:Kprim

a) **Ursache ist häufig eine Insuffizienz des urethralen Verschlussmechanismus.**
b) **Ein unwillkürlicher Urinverlust tritt typischerweise bei körperlicher Belastung auf.**
c) Die urodynamische Untersuchung ist für die Erstdiagnose obligat.
d) Eine verminderte urethrale Mobilität ist eine typische Ursache der Belastungsharninkontinenz.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

17. Welche Aussagen zum Descensus genitalis treffen zu?

Typ: PickS

a) **Der Descensus genitalis ist definiert als eine Senkung der Beckenorgane infolge einer Beckenbodeninsuffizienz.**
b) **Der POP-Q-Score dient der standardisierten klinischen Klassifikation des Descensus.**
c) **Eine vaginale Geburt stellt einen relevanten Risikofaktor dar.**
d) Ein Descensus ist immer mit Harninkontinenz assoziiert.
e) Eine konservative Therapie mit Pessar sollte nur bei älteren Patientinnen erfolgen.
f) Eine prophylaktische Hysterektomie reduziert unabhängig vom Kompartiment das Rezidivrisiko eines Descensus.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

18. Welche der folgenden Aussagen zur überaktiven Blase (Overactive Bladder, OAB) trifft bzw. treffen zu und welche nicht?

Typ: Kprim

a) **Das Leitsymptom ist ein imperativer Harndrang mit oder ohne begleitende Harninkontinenz.**
b) Eine probatorische antibiotische Therapie ist primär indiziert.
c) Bulking Agents stellen ein etabliertes operatives Therapieverfahren dar.
d) **Nykturie gehört zu den typischen Symptomen der überaktiven Blase.**

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

Eine pathogische Geburt äußert sich beispielsweise durch einen protrahierten Geburtsverlauf oder sogar einen Geburtsstillstand.

--

19. Gibt es bei den beschriebenen Fallkonstellationen ein höheres Risiko für eine protrahierte Geburt oder einen Geburtsstillstand?

Typ: Kprim

a) **Eine normgewichtige Frau IG in der Schwangerschaftswoche (SSW) 39+3 und fetaler Makrosomie mit Polyhydramnion bei einem insulinpflichtigen Gestationsdiabetes.**
b) **Eine adipöse Frau VIIG VP in der SSW 41+3 und einem Uterus myomatosus**
c) **Eine Frau IIG IP in der SSW 36+3 und dichorialer diamnialer Geminigravidität (Beide Feten liegen in Schädellage. Das berechnete Schätzgewicht aus den Ultraschalluntersuchungen liegt bei beiden Feten auf der 80. Perzentile)**
d) **Eine sportliche Frau IG in der SSW 40+1, einem vollständig eröffneten Muttermund und einer hinteren Scheitelbeineinstellung.**

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

20. Welche der folgenden Aussagen zur Plazenta prävia treffen zu?
Typ: PickS

a) **Eine Plazenta prävia totalis liegt vollständig über dem inneren Muttermund und führt häufig zu einer Lageanomalie des Fetus.**
b) **Risiken für eine Plazenta prävia sind Voroperationen am Uterus wie eine Sectio, Myomenukleationen oder Kürettagen**
c) Eines der Leitsymptome einer Plazenta prävia-Blutung ist die schmerzhafte Blutung bei einem tonisierten Uterus.
d) **Die Blutung bei einer Plazenta prävia ist potentiell lebensbedrohlich für Mutter und Kind.**
e) Bei einer tiefsitzenden Plazenta ist eine vaginale Entbindung wegen des zu erwartenden Blutungsrisikos nicht zu empfehlen.
f) Der Nachweis einer Plazenta prävia sollte durch eine vaginale Tastuntersuchung erfolgen.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

Bei einer 34-jährigen Frau IG in der Schwangerschaftswoche 40+2 besteht ein protrahierter Geburtsverlauf. Trotz Unterstützung mittels Oxytocinperfusor gibt es keinen Geburtsfortschritt. Bei einem Höhenstand des fetalen Köpfchens auf Beckenmitte führen Sie eine Vakuumextraktion nach entsprechender Aufklärung und Einwilligung der Gebärenden durch. Nach 3 Traktionen kommt es zur Kopfgeburt. In der nächsten Wehe folgen die Schulter und der restliche Körper des Kindes nicht. Das Köpfchen ist nicht vollständig ausrotiert und wirkt aufgepresst.

--

21. Welche Aussage trifft am ehesten zu?

Typ: TypA

a) Wegen der Wehenschwäche sollten Sie unbedingt das Oxytocin steigern, um so die Geburt zu ermöglich.
b) **Sie informieren das gesamte Team und führen gemeinsam mit der Hebamme mehrmals ein langsames Überstrecken und Beugen der maternalen Beine in der Hüfte durch.**
c) Nach Hinzurufen einer weiteren Hebamme beschleunigen Sie durch eine Traktion und Drehung am kindlichen Köpfchen die Geburt.
d) Da bereits das Kind nach der Kopfgeburt atmen kann, gibt es kein Hypoxierisiko.
e) Der Grund für die ausbleibende Geburt ist ein Verkeilen des kindlichen Bauches am Nabelschnuransatz hinter der maternalen Symphyse.

--

Deleted: mit
Deleted: 39+3
Deleted: n
Deleted: mit
Deleted: 41+3
Deleted: mit
Deleted: 36+3
Deleted: mit
Deleted: 40+1

Deleted: mit
Deleted: 40+2
Deleted: n
Deleted: (SSW)

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

Eine 32-jährige Frau G2P0 stellt sich in der 23 + 5 Schwangerschaftswoche (SSW) in der geburtshilflichen Notaufnahme vor. In der Vorgeschichte berichtet sie über einen Spätabort in der 20. SSW aufgrund einer schmerzlosen Muttermundseröffnung. Die Patientin klagt aktuell über vermehrten vaginalen Druck, aber **keine Wehen**, kein Fieber und keinen vorzeitigen Blasensprung.

Deleted: SSW

In der transvaginalen Sonographie zeigt sich eine **Zervixlänge von 14mm** mit **trichterförmiger innerer Muttermundöffnung**. Der CTG-Befund ist unauffällig.

Zur weiteren Abklärung wird ein **PartoSure®-Test** durchgeführt, der **negativ** ausfällt.

--

22. Welche der folgenden Aussagen zur weiteren Diagnostik oder Therapieoption ist **am ehesten zutreffend?**

Typ: TypA

a) Der negative PartoSure®-Test schließt eine Zervixinsuffizienz aus, sodass keine weitere Intervention notwendig ist.
b) Aufgrund der sonographischen Befunde sollte primär eine Tokolyse begonnen werden, da ein drohender vorzeitiger Wehenbeginn vorliegt.
c) Der PartoSure®-Test dient dem Ausschluss einer Infektion der Amnionhöhle und ist hier zur Entscheidung über eine antibiotische Therapie entscheidend.
d) Trotz negativem PartoSure®-Test ist aufgrund der Vorgeschichte und der sonographischen Befunde von einer Zervixinsuffizienz auszugehen, sodass eine cerclage- oder pessarbasierte Therapie erwogen werden sollte.
e) Bei negativer PartoSure®-Diagnostik ist eine vaginale Progesteronsubstitution kontraindiziert.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

Eine 28-jährige Frau I Gravida/ 0 Para stellt sich bei Ihnen in der 27+6 Schwangerschaftswoche wegen reduziertem Allgemeinzustand mit Ohrensausen, Kopfschmerzen, ausgeprägten Ödemen an den Extremitäten und Oberbauchschmerzen vor. Sie messen bei der Patientin einen Blutdruck von 141/107 mmHg. Die Eiweißausscheidung im Urin beträgt 400 mg/d. Serologisch lassen sich eine milde Thrombozytopenie von 140.000/µl, ein Hämoglobin-Wert von 10,2 g/dl sowie eine Harnsäure von 7 mg/dl nachweisen. Der sFlt-1/PlGF-Quotient weist einen Wert von 91 auf. Die Reflexe sind physiologisch.

Deleted: mit

Deleted: SSW

Biometrie, Fruchtwasser, Doppler und CTG sind unauffällig.

--

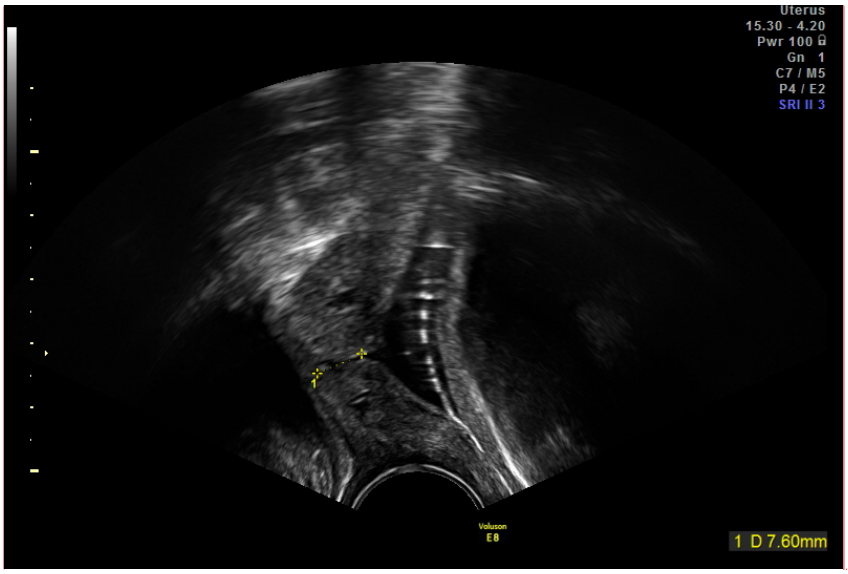
23. Entscheiden Sie bei jeder Antwort, ob diese korrekt ist:

Typ:Kprim

a) Der Flt-1/PlGF-Quotient hat einen diagnostischen Stellenwert im oben geschilderten Fall.
b) Es handelt sich um eine Early-onset Präeklampsie.
c) Es handelt sich um ein HELLP-Syndrom.
d) Das Alter der Patientin stellt einen Risikofaktor für eine Präeklampsie dar.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26



Quelle: Universitätsklinikum Würzburg

--

24. Welche der folgenden Aussagen zu diesem Sonographie-Befund ist bzw. sind korrekt?

Typ: Kprim

a) Es muss von vorzeitiger Wehentätigkeit ausgegangen werden.
b) Die Zervix ist verkürzt und weist einen Trichter auf.
c) Zur Beurteilung der Zervixlänge sollten drei Messungen durchgeführt werden.
d) Die Zervixlänge ist für eine Schwangere in der 35. SSW unauffällig.

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

25. Welche Aussage zur Nachgeburtsphase trifft am ehesten zu?

Typ: TypA

a) Sie endet mit vollständiger Muttermundseröffnung
b) Sie umfasst die Lösung und Geburt der Plazenta
c) Sie beginnt erst nach dem ersten Stillen
d) Sie dauert physiologisch bis zu 3 Stunden
e) Sie endet mit dem Einsetzen des Pressdrangs

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

Commented [EA5]: Bildzuschnitt in Word unwirksam. CaseTrain liest das ganze Bild ein. Das Bild soll außerhalb von Word in einem Editor bearbeitet werden. Auch stimmen die Quellangaben nicht. (Inselspital Basel nicht UKW)

Commented [EA6]: Angepasst zum Format bei anderen KPrims der Klausur nur...

Deleted: (

Deleted:)

Deleted: /

26. Welche Aussage zum CTG trifft am ehesten zu?

Typ: TypA

a) Eine Baseline von 90/min ist physiologisch
b) Dezelerationen zeigen immer eine fetale Gefährdung an
c) Akzelerationen sprechen für eine gute fetale Reaktion
d) Eine Baseline von 200/min ist normal
e) Variabilität < 5/min ist immer unbedenklich

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

27. Welche Aussage zur Geburtsmechanik trifft am ehesten zu?

Typ: TypA

a) Maximale Flexion des Kopfes im Beckenausgang
b) Extension des Kopfes im Beckeneingang
c) Seitneigung des Kopfes zur Anpassung an den schrägen Durchmesser
d) Deutliche Zunahme des biparietalen Durchmessers
e) Rotation der Schultern vor der Geburt des Kopfes

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

Fallbeispiel A Frage 1 von 2

Die kommenden beiden Fragen gehören zu einem Fallbespiel. Sie haben nach dem Eintragen Ihrer Antwort keine Möglichkeit der Korrektur. Lediglich die Antwort der letzten Frage dieses Falles kann nachträglich geändert werden.

Ein Elternpaar erwartet das zweite gemeinsame Kind. Das erste Kind benötigte aufgrund eines deutlich erhöhten Bilirubinwertes nach der Geburt eine Fototherapie.
Die Blutgruppe der Mutter ist A Rhesus negativ (ccddee), die Blutgruppe des Kindsvaters A Rh positiv (CCD.EE).
In der aktuellen Schwangerschaft wurde in der zehnten Schwangerschaftswoche ein irregulärer Antikörper (Anti-D-Antikörper) bei der Mutter festgestellt.
Sequenz: A
--

28. Wofür besteht in der aktuellen Schwangerschaft ein hohes Risiko?
Typ: TypA

a) fetale Spina bifida
b) Präeklampsie
c) fetale Mikrozephalie
d) Plazenta praevia
e) **fetale Anämie**

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

Fallbeispiel A Frage 2 von 2

Die eingetragene Antwort dieser letzten Frage dieses Falles kann nachträglich geändert werden.

Sequenz: A
--

29. Mit welcher dopplersonographischen Untersuchung ist die Ausprägung einer fetalen Anämie in der Regel abschätzbar? Doppleruntersuchung der ...
Typ: TypA

a) Arteria umbilicalis
b) Arteria uterina
c) **Arteria cerebri media**
d) Arteria radialis
e) Arteria renalis

--

Titel: Klausur Gynäkologie und Geburtshilfe WS 2025/26

--

30. In welcher der genannten Situation ist das Ergebnis des nicht-invasiven Pränataltests (NIPT) in der Regel trotz Pathologie unauffällig („falsch-negatives“ Ergebnis):
Typ: TypA

a) „vanishing twin“-Situation
b) Systemischer Lupus erythematodes (SLE) der Mutter
c) Adipositas der Mutter
d) Maligne Erkrankung der Mutter
e) **Fetale Triploidie**

--

Commented [EA7]: TypA Frage, Pluralform hier nur irreführend...

Deleted: /welchen

Deleted: (en)